

Hemiplejía severa post-ACV en el Perú

Población

El MINSA señala que el ACV isquémico es la segunda causa de muerte en el país, y una de las primeras causas de discapacidad permanente en adultos [1]. El 15 % de las muertes prematuras en el Perú se atribuyen a enfermedad cerebrovascular [2], con una mortalidad hospitalaria de 19,6 a 20 % y otro 20 % adicional al año del evento [2]. La incidencia se ubica en 85 a 87 casos por cada 100 000 habitantes, con una prevalencia de 6,47 por 1 000 que sube con la edad a partir de los 55 años [3]; en mayores de 65 años, el ACV representa el 28,6 % de las causas de muerte en zona urbana y el 13,7 % en zona rural [3].

El país no sabe con precisión cuántos casos tiene. Bernabé-Ortiz señala una vigilancia limitada, sin incidencia poblacional confirmada por subtipo, con la mayoría de cifras provenientes de modelos matemáticos internacionales [4]. Se le ha llamado, en la literatura peruana, una enfermedad prevalente olvidada y desatendida [5]. Y como el Perú envejece cada vez más, la carga de secuelas de ACV va a seguir creciendo más allá de que mejore o no el manejo agudo.

Problemática

La mitad de los eventos son de severidad moderada a grave, el sistema tiene capacidad limitada para dar rehabilitación temprana adecuada, y en consecuencia la funcionalidad medida al año se mantiene igual que al alta [2]. No es que los pacientes mejoren poco: medido a un año, no mejoran. Esto se confirma con la cohorte peruana del estudio INTERSTROKE, donde menos de la mitad volvía a consulta al mes del alta y no se observó mejoría funcional respecto al alta [2].

El costo humano es concreto: el 60 % de los dados de alta permanecen con secuelas discapacitantes, el 40 % tiene severa dificultad para caminar un kilómetro, y el 28 % permanece con incontinencia urinaria [5]. A eso se suma el costo indirecto: la discapacidad motora crónica retira de la actividad económica al paciente y, en parte, a un cuidador familiar.

Los pocos que llegan a un servicio especializado, llegan tarde. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, el 87,6 % de los atendidos presentaba secuelas moderadas o severas [6], lo que indica que el paciente no llega dentro de la ventana de neuroplasticidad óptima (los primeros tres a seis meses), sino cuando el déficit ya se consolidó.

Causas

El referente nacional de rehabilitación especializada es, en la práctica, uno solo: el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú-Japón, en Lima, que solo entre enero y junio de 2026 registró 180 422 atenciones [7]. Un único instituto absorbiendo la demanda de 33 millones de habitantes, con geografía fragmentada, significa que fuera de Lima la rehabilitación especializada existe en el papel, pero no en la práctica.

Para el 2015 solo 3 hospitales en el Perú contaban con unidades de ictus [8]. El diferimiento promedio en EsSalud es de 23 días, y llega hasta 80 días en rehabilitación pediátrica en Lima [9]. (Cifras de más de 90 días en el sur y oriente circulan en fuentes secundarias poco confiables y deben verificarse antes de usarse formalmente.) A esto se suma la pérdida del seguimiento tras el alta, ya mencionada [2], incompatible con una rehabilitación que necesita continuidad de meses, y una terapia convencional que opera con un terapeuta por paciente, lo que limita cuánta rehabilitación puede sostener el sistema por cada hora de personal disponible.

Todo esto ocurre sobre una base de infraestructura débil: el 95,89 % de los establecimientos del primer nivel carece de condiciones mínimas para funcionar, y hay al menos 55 obras de salud paralizadas por unos S/ 4 574 millones [10]. No es solo que falte personal o tiempo, es que buena parte del sistema donde debería darse esta rehabilitación tampoco está terminado de construir.

Exclusión

La mayoría de protocolos de rehabilitación activa (terapia convencional, CIMT, terapia en espejo) exige que el paciente conserve algún movimiento voluntario residual: la revisión Cochrane sobre CIMT en pacientes con ACV incluyó únicamente a quienes conservaban al menos 10 grados de extensión activa de muñeca y cierto potencial de recuperación motora, excluyendo explícitamente a los casos sin ese remanente [11]. El paciente con hemiplejía severa, sin contracción visible, queda relegado a movilización pasiva y prevención de contracturas: se evita que empeore, pero no se busca que mejore.

Referencias

- [1] Ministerio de Salud del Perú (MINSA), "Accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad permanente en edad adulta."
- [2] "La enfermedad cerebrovascular en el Perú: estado actual y perspectivas de investigación clínica," Rev. Soc. Peru. Med. Interna, vol. 31, no. 1, 2018.
- [3] Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, "Boletín Epidemiológico N.º 8," Lima, Perú, 2022.
- [4] A. Bernabé-Ortiz, "Tasa de incidencia del accidente cerebrovascular en el Perú," Rev. Peru. Med. Exp. Salud Publica, vol. 38, no. 3, 2021.
- [5] "El accidente cerebrovascular en el Perú: una enfermedad prevalente olvidada y desatendida," Rev. Peru. Med. Exp. Salud Publica, vol. 31, no. 2, pp. 400-401, 2014.
- [6] F. Urcia-Fernández y D. Cam-Chiok, "Perfil epidemiológico de los pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular atendidos en un instituto de rehabilitación de Lima-Perú," Rev. Med. Hered., vol. 34, no. 3, pp. 132-134, 2023.
- [7] Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú-Japón, Oficina de Estadística e Informática, "Reportes de producción asistencial," Lima, Perú, 2026.
- [8] "Tendencia de mortalidad por enfermedad cerebrovascular registrada por el MINSA, 2005-2015," Neurología Argentina, 2019.

[9] El Comercio, "Salud en espera" (informe especial), Lima, Perú, 2026.

[10] Contraloría General de la República del Perú, "Informe sobre obras de salud paralizadas," Lima, Perú, mar. 2026.

[11] D. Corbetta, V. Sirtori, L. Castellini, C. Moja, and R. Gatti, "Constraint-induced movement therapy for upper extremities in people with stroke," *Cochrane Database Syst. Rev.*, no. 10, art. no. CD004433, 2015, doi: 10.1002/14651858.CD004433.pub3.